Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Fausse route / Obstruction des voies aériennes

Aliment ou objet qui bloque la respiration : laisser tousser, désobstruer si la toux est inefficace. Adulte, enfant (IME), troubles de déglutition (MAS, FAM, EHPAD).

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne peut plus parler, tousser ni respirer, mains à la gorge, lèvres bleues, perte de connaissance.

1 · Je sécurise

- J'**arrête** le repas ou la boisson ; je reste avec la personne.
- J'appelle à l'aide ; obstruction complète : un collègue **appelle le 15**.
- En fauteuil : **freins serrés**, personne penchée en avant.
- Enfant (IME) : mêmes gestes, sauveteur à genoux ; nourrisson : compressions **thoraciques**.

2 · Toux efficace ou non ?

- Tousse fort, parle, crie, pleure, respire : **obstruction partielle**.
- Ne peut plus parler, tousser ni respirer, devient bleu : **obstruction complète**.
- Personne qui ne parle pas : arrêt brutal du repas, agitation, regard paniqué, bruit respiratoire.
- Troubles de déglutition connus ? Texture prescrite respectée (eau gélifiée, mixé) ?

3 · J'agis selon la toux

- Partielle : l'**encourager à tousser**, l'installer au mieux, surveiller.
- Complète : **1 à 5 claques** vigoureuses entre les omoplates, penchée en avant.
- Sans effet : **1 à 5 compressions abdominales** (creux de l'estomac) ; alterner les deux.
- Enceinte, obèse, alitée ou impossible à encercler : **compressions thoraciques**.
- Perd connaissance : au sol, **RCP** ; à chaque cycle, retirer l'objet s'il est visible.

Je ne fais pas

- Mettre les doigts dans la bouche **à l'aveugle**.
- Donner à boire pour « faire passer » ; allonger une personne qui respire mal.
- Reprendre le repas après un épisode sévère sans avis de l'IDE.
- Modifier de moi-même la texture prescrite (eau gélifiée, mixé).

J'alerte

Appel 15 :

- **Obstruction complète**, dès le début.
- Perte de connaissance : RCP (« Arrêt cardio-respiratoire »).
- Désobstruction **réussie** : appeler quand même.
- Gêne persistante, lèvres bleues, SpO2 < 90 %.

J'appelle l'IDE (ou astreinte, DOTR) :

- Toute fausse route, même résolue par la toux.
- Toux au repas répétée, voix « mouillée », fièvre ou encombrement après un repas.

Je surveille et je trace

- Tracer : heure, aliment, texture servie, gestes faits, résultat, qui a été prévenu.
- Les jours suivants : toux, fièvre, encombrement, SpO2 < 90 % → IDE (infection pulmonaire possible).
- Signaler à l'IDE pour réévaluer déglutition et texture (médecin, orthophoniste).

Mention de sécurité

Toux efficace : laisser tousser. Toux inefficace : claques puis compressions, sans attendre. Après toute désobstruction : avis médical.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ERC Guidelines 2025 First Aid et Adult Basic Life Support (Resuscitation 2025;215) ; Resuscitation Council UK, First Aid Guidelines (27/10/2025) ; DGSCGC, recommandations PSC1, fiches obstruction et désobstruction (12/2023).

Réf. DOTR-AS-FR | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature